22. EL HÍGADO : GENERALIDADES

DURACIÓN : 11:53 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el complejo origen embriológico del hígado, constituido por tejidos provenientes del intestino superior, medio e inferior, así como de estructuras mesodérmicas esenciales. Detalla la dualidad funcional del hígado, actuando tanto como glándula exocrina para la secreción de bilis como glándula endocrina gracias a su componente mesodérmico. También se aprende la importancia del crecimiento embrionario y de la hemodinámica en el desarrollo de este órgano vital. Además, el video subraya la integridad funcional y las relaciones anatómicas entre el hígado y el diafragma, ilustra cómo los desequilibrios pueden conducir a disfunciones, al tiempo que insiste en el papel del diafragma como "puerta de la vida" que influye directamente en la salud hepática.

EL HÍGADO: GENERALIDADES

1. ORIGEN EMBRIOLÓGICO DEL HÍGADO

El **hígado** tiene un origen embriológico complejo, formado por tres partes:

- El intestino superior
- El intestino medio
- El intestino inferior

La unión entre el intestino superior y el intestino medio es el asiento de un fenómeno de aspiración, que se denomina campo metabólico de **loosing fields**. Este campo de aspiración inicia el desarrollo del hígado.

Al observar un corte histológico, se constata que este tejido, inicialmente un conjunto de células, sufre un movimiento de aspiración. Debajo de este tejido primordial se encuentra un tejido **mesodérmico**, que incluirá más tarde el sistema arterial del hígado, de origen vitelino.

Este proceso de aspiración y fracturación es común al desarrollo de todas las glándulas. Cada pequeña yema recrea un nuevo campo de aspiración, formando así un conjunto de pequeños canales, los **canales hepáticos**.

2. DISTINCIÓN ENTRE GLÁNDULAS EXOCRINAS Y ENDOCRINAS

Existen dos tipos de glándulas: **exocrinas** y **endocrinas**.

- Una glándula endocrina pierde su luz y secreta su sustancia directamente en la sangre.
- El hígado, en cambio, es una glándula exocrina. Secreta sus sustancias biliares dentro de su luz, devolviendo los azúcares necesarios para la digestión al sistema digestivo.

En resumen, el hígado es un campo de aspiración que se asocia con el mesodermo, particularmente con los vasos de origen vitelino, para formar su estructura. Procede del intestino, pero integra componentes mesodérmicos.

3. DOBLE FUNCIÓN ENDODÉRMICA Y MESODÉRMICA DEL HÍGADO

El hígado posee una **doble función**:

- **Función endodérmica:** de tipo digestivo y cannobiliar especializada, caracterizada por el ciclo **enterohepático**, muy importante para la secreción de la bilis que luego es reabsorbida a nivel cecal.
- **Función mesodérmica:** una función endocrina, ligada a su componente mesodérmico.

Esta dualidad explica cómo el hígado, incluso después de una ablación parcial, puede regenerarse en su estructura mesodérmica.

4. PAPEL DEL HÍGADO EN EL CRECIMIENTO Y LA HEMODINÁMICA

Para que haya un campo de aspiración, se necesita una fase de **crecimiento longitudinal** del embrión. Este campo de aspiración está, por lo tanto, ligado al crecimiento, participando en los procesos de **cefalización**, **cardialización** y **hepatización**.

La función primaria del hígado es esencialmente **hemodinámica** y permite un potencial de vida. Su primer impulso es recibir los productos de desasimilación, es decir, los productos catabólicos de todo el cuerpo.

Esto significa que el hígado está fundamentalmente diseñado para participar en la **regeneración**. Es el órgano principal de la regeneración corporal, ya sea a nivel tendinoso, muscular o de otras estructuras.

El hígado recibe múltiples informaciones: portales, linfáticas y cardíacas.

5. INTEGRIDAD FUNCIONAL Y RELACIONES ANATÓMICAS

En osteopatía, la pérdida de **integridad funcional** del hígado con el diafragma es crucial. El **ligamento triangular**, el **ligamento falciforme**, y la envoltura del hígado están en continuidad tisular, celular e incluso molecular con el diafragma y el pericardio.

Este origen supera la placa precordial. Células **mesenquimales** indiferenciadas, procedentes de esta zona, dan origen al **septum transverso** y al pericardio.

El septum transverso, entre otras cosas, forma el ligamento triangular del hígado que se prolonga por el ligamento falciforme hepático. También contribuye al **gran epiplón** (omento mayor).

El corazón, el diafragma y una parte del hígado están íntimamente ligados. El hígado actúa como un punto de apoyo que contribuye indirectamente a la formación de los pilares diafragmáticos.

El septum transverso, en asociación con el pericardio, permanece estable, mientras que las estructuras circundantes crecen a su alrededor, formando esta integración por el movimiento de desarrollo cerebral.

Un desequilibrio simple, como un desplazamiento costal, puede afectar la posición del diafragma y del hígado.

6. EL DIAFRAGMA: PUERTA DE LA VIDA

El diafragma es a menudo designado como la **"puerta de la vida"** debido a sus orificios y a su papel esencial. La interacción con el hígado es central.

El movimiento rítmico del diafragma, con aproximadamente **23.000 respiraciones al día**, hace que el trabajo del hígado dependa del movimiento diafragmático y pulmonar.

Observamos presiones diferenciales en el cuerpo:

- Presión negativa a nivel pulmonar.
- Presión positiva a nivel abdominal.
- Presión negativa a nivel pélvico.
- Presión positiva en la parte superior del cuerpo.

7. IMPORTANCIA DE LA NORMOTENSIÓN ABDOMINAL

La **normotensión abdominal** es una referencia importante: la tensión epigástrica es ligeramente superior a la tensión hipogástrica.

- Una hipertensión abdominal frecuente puede aumentar la tensión en la zona alta y disminuir la fuerza en las zonas bajas.
- Tratar esta zona a menudo implica considerar la zona depresiva.
- Tratar los pulmones equivale a tratar el peritoneo.

La desestabilización de una parte conlleva la desestabilización de la otra. Por lo tanto, es crucial trabajar en los espacios de **volemia** para apoyar el proceso diafragmático. El hígado, al ser voluminoso, y su proximidad con el corazón y los pulmones, crea un espacio de intercambio vital.

Es necesario determinar el tipo de tensión abdominal y trabajar en los esquemas volémicos. Apoyar esta zona es esencial porque una pérdida de función aquí disminuirá la vitalidad global. El diafragma se esforzará entonces por mantener el equilibrio.

8. HÍGADO, LÍQUIDOS Y RELACIONES CARDÍACAS

El hígado gestiona las cualidades de los **líquidos** intercambiados, especialmente para la digestión y el volumen.

Cuantifica y modifica la tensión portal que transmite al corazón. En realidad, el hígado es una especialización del **duodeno**, que recibe una multitud de informaciones (autocrinas, paracrinas, neurocrinas, endocrinas).

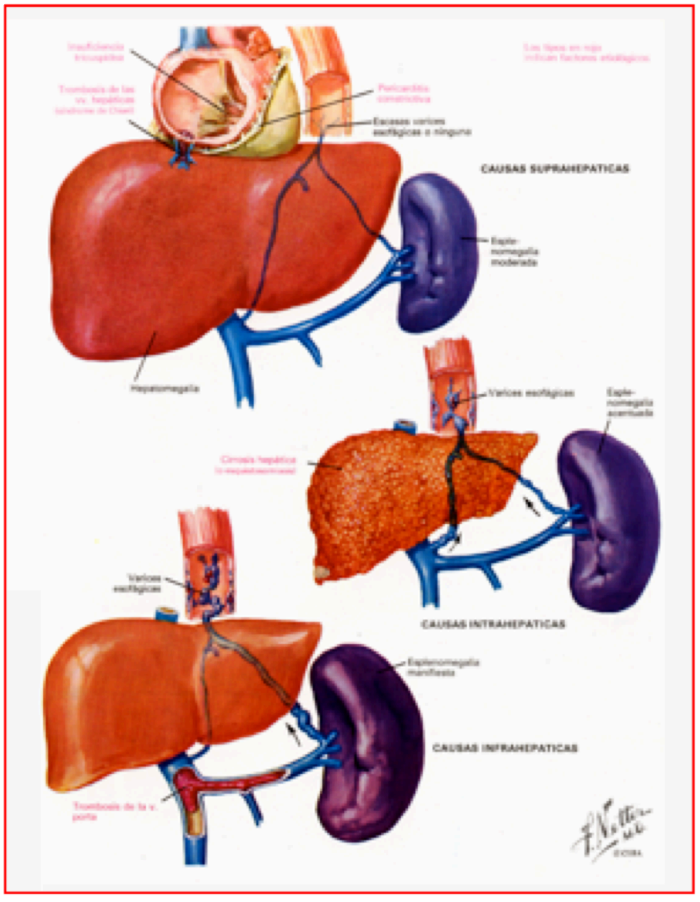


FIG. — Hipertensión portal

El duodeno es una encrucijada de informaciones para el páncreas y el hígado, proporcionando informaciones digestivas en función de los aportes. Un buen estado digestivo es, por lo tanto, primordial.

Cuando el hígado pierde sus movimientos y la calidad de sus intercambios, especialmente a nivel linfático, esto puede desestabilizar el corazón y enfermarlo. Existe una relación muy importante entre el corazón y el hígado.

- Si el hígado comienza a desestabilizarse, el corazón puede enfermar.
- Inversamente, aliviar el hígado puede ayudar a un corazón sufriente.

Muchas afecciones cardíacas son en realidad **disfunciones metabólicas** del hígado.

9. HÍGADO Y SISTEMA LINFÁTICO

El hígado puede sobrecargar el **sistema linfático**, lo que a su vez sobrecarga el conducto linfático principal y el plexo neurológico lateral de la cadena simpática, provocando repercusiones a distancia.

Por ejemplo, un hombro izquierdo doloroso puede ser un signo de **congestión hepática**. Estos son indicadores tempranos de un desajuste hepático, siendo el gran conducto primario primero a la izquierda.

No hay que olvidar la **"trinidad"** corazón-hígado-bazo, a la que se añade el sistema mesentérico. Estas "esponjas" o estados de volemia funcionan en sinergia.

El eje entre el hígado y el corazón es la **vena cava**, cuya construcción es compleja.

10. HÍGADO Y SISTEMA INMUNITARIO

Existe una relación inmunitaria importante que involucra al **sistema tímico**. El hígado está implicado en el paso de los **linfocitos T** con el timo, y el retorno de las informaciones inmunitarias a través del bazo. Este proceso contribuye al equilibrio tímico y a la maduración de los linfocitos T.

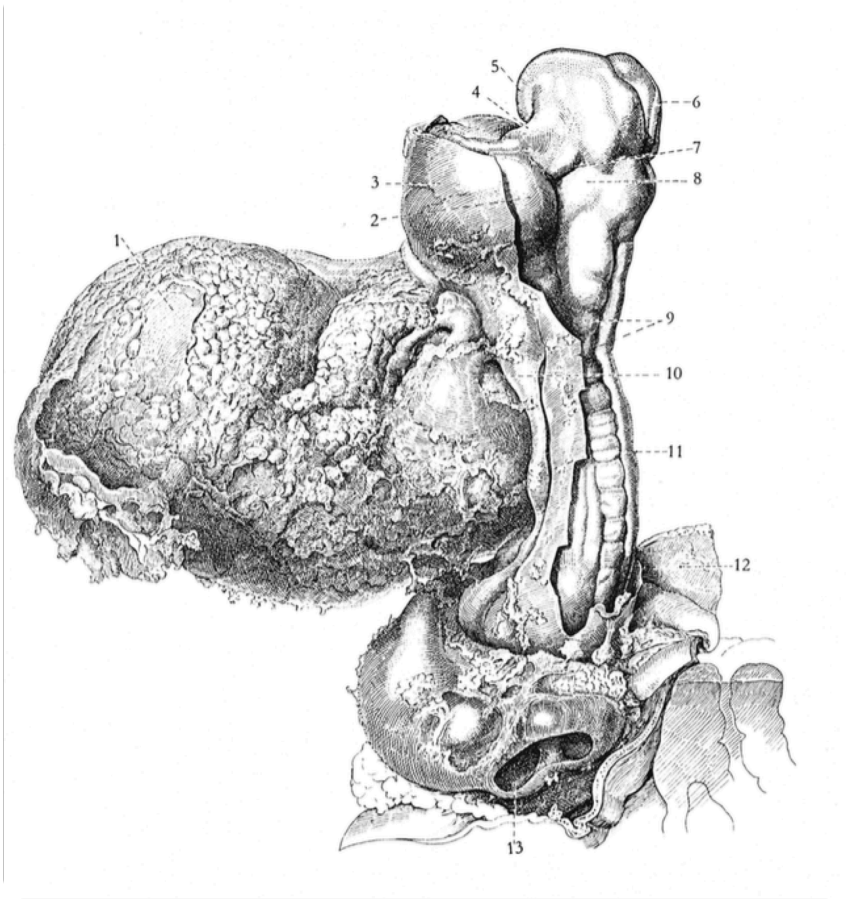


FIG. — Disección de embrión humano